

기억력 장애 및 성격 변화를 주소로 내원한 75세 여성

증례

75세 여성이 기억력 장애 및 성격 변화를 주소로 딸과 함께 방문하였다. 기억력은 3년 전(2021년) 남편 사별 이후 서서히 저하된다고 하며, 1년 전부터는 성격 변화도 나타난다고 하였다.

책을 읽은 뒤에 어떤 내용이었는지 기억이 나지 않을 때가 있으며 물건을 가지러

방에 들어갔다가 어떤 물건을 가지러 가려고 했는지 기억이 나지 않아 한참 생각할 때가 있다고 했다. 장을 볼 때도 메모를 하지 않으면 물건 몇 가지를 사지 못하는 경우도 있었다. 약속은 스스로 잘 챙기고 있으나 약속을 놓칠까 봐 불안하여 이전보다 핸드폰을 자주 보게 된다고 한다.

작년부터 사소한 일에도 예민하게 반응

하고 소리를 지르며 화를 내는 일이 잦아졌다. 본래 걱정이 많은 편이었지만 최근에는 일어나지 않은 일로도 불안해하거나 안절부절하는 등 성격 변화가 보인다. 정확한 시점은 알 수 없으나, 환자는 수면 중에 혼자서 웅얼거리는 잠꼬대를 한 적이 한 번 있었고, 최근에는 악몽을 자주 꾸어 수면에 어려움이 있다.

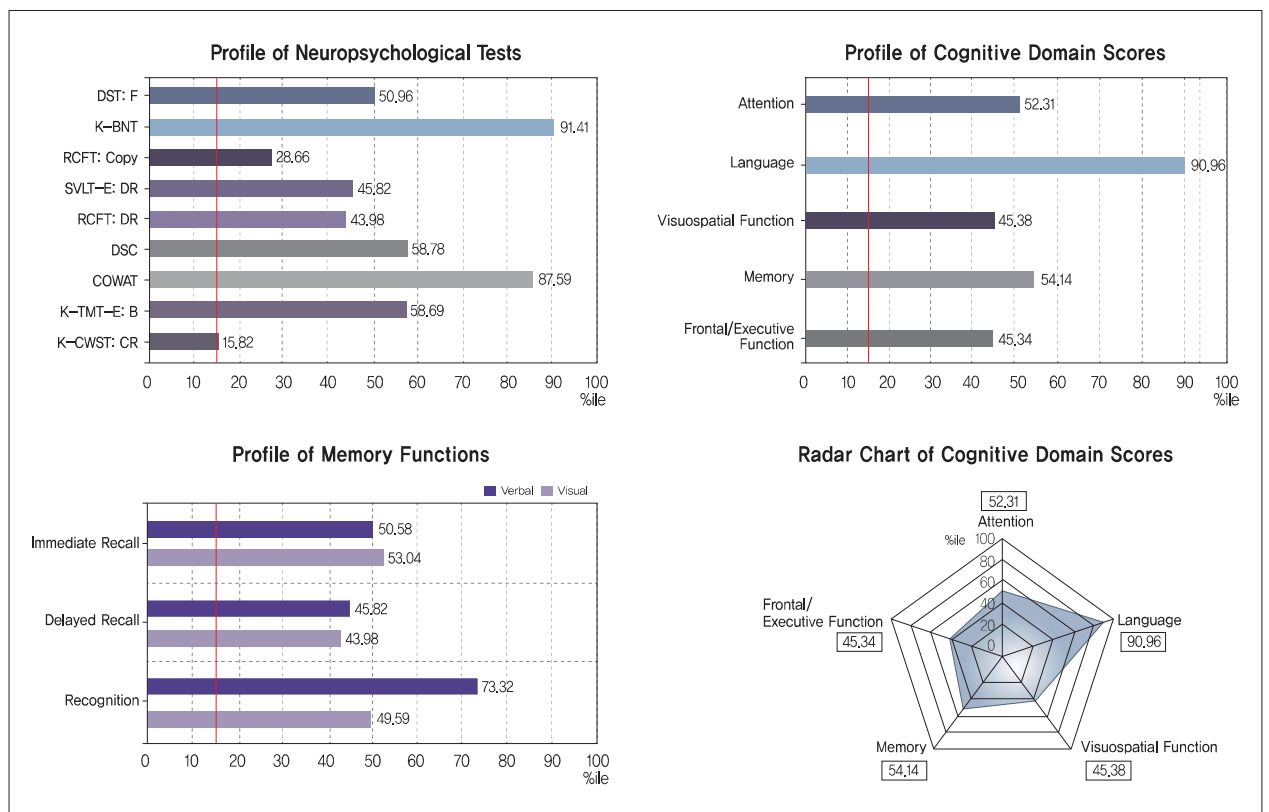


그림 1.

혼자서 익숙한 장소를 잘 다니고 있으며, 멀고 낯선 곳에 갈 때도 미리 길을 알려 주면 특별한 어려움 없이 길 찾기가 가능하고 방향 감각이 잘 유지되고 있다. 아직까지 환자에게 중요했던 일의 대부분은 기억할 수 있으며, 기억하지 못하는 부분에 대해서 힌트를 주면 기억해 낼 수 있었다. 약 복용을 스스로 챙기는 등 일상 생활은 큰 어려움 없이 유지되고 있다. 개인 위생 관리의 문제없이 하고 있고, 집안일도 큰 문제없이 스스로 하고 있으며, 최근까지 김치를 담거나 반찬을 만들고 있으며 맛의 변화도 없다. 환자는 주 1회 노래교실에 가고 있고, 주 3회 수영장에서 아쿠아로빅을 배우고 있다. 운동이 끝난 뒤 사람들과 함께 식

사를 하는 등 모임에도 적극적으로 참여하고 있다. 은행업무는 본래 딸이 대신하고 있으며, 환자는 장을 보거나 정확한 계산을 하는데 문제가 없다. 최근에 핸드폰으로 사진을 찍는 기능을 배워서 스스로 사용하는 등 큰 어려움이 없다.

초졸 학력의 환자는 의류공장에서 10년간 일한 적이 있으며, 최근까지는 주부로 지냈다. 환자는 2021년에 남편과 사별한 뒤로 딸과 함께 거주하고 있으며, 남편과의 사이에서 1남 1녀를 두었다. 술은 가끔씩 소주 1~2잔 정도를 마시며 담배는 전혀 하지 않았다. 1년 전에 우울증 관련 약을 6개월 정도 복용하였다. 현재, 당뇨병 관련 약을 복용하고 있으며, 가끔 소염진통제나 어지

림증 관련 약을 복용 중이다.

신경심리검사 결과, K-MMSE(한국형 간이정신상태검사) 점수는 29으로, 주의집중 및 계산에서 4점(5)이었으며, SNSB(서울신경심리검사) 결과도 모든 인지 영역에서 이상을 보이지 않았다(그림 1). CDR(임상치매척도) 0.5점(SOB 1점), KIADL(한국형도구적일상생활수행능력척도) 0.2점으로, 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)로 진단하였다.

인지 기능 저하는 관찰되지 않았지만, CGA-NPI(이상행동평가) 5점(144)으로 비협조적인 행동/공격성(1), 불안(1), 화를 잘냄(2), 식습관, 식욕의 변화(1) 이상을 호소하였으며, MBI-C(경도행동장애체

Mild Behavioral Impairment Checklist (MBI-C)

검사일: _____

평가자: ☐ 의사 ☐ 보호자 ☐ 환자

장 소: ☐ 클리닉 ☐ 연구

다음의 행동이나 기분(노출)에 **참조 6개월 이상** (예측해서 또는 간헐적으로) 나타났고, 원래의 행동 패턴과 **달라진 경우에만**, "예"에 동그라미를 하세요. 그렇지 않으면 "아니오"에 동그라미를 하십시오.

"예"에 동그라미를 하신 경우에만 심각도를 표시해 주세요: 1 = **경증** (뚜렷하지만, 의미 있는 변화는 아니다); 2 = **보통** (의미 있는 변화이지만, 극적인 변화는 아니다); 3 = **심함** (매우 현저하고, 극적인 변화이다). 단일 한 질문이 여러 가지 내용을 포함하고 있고 각각의 심각도가 다르다면, 그 중 가장 심각한 수준으로 표시해 주세요.

	예	아니오	심한 정도
흥미, 동기 및 욕구에 관한 질문입니다.			
친구나 가족 또는 집안일에 대해서 관심(흥미)을 잃었습니까?	예	아니오	1 2 3
예전에는 관심이 있던 일들이나 주제에 대해서 호기심이 줄었습니까?	예	아니오	1 2 3
전보다 덜 자발적이거나, 덜 적극적입니까? 예를 들어, 자신이 먼저 대화를 시작하려고 하지 않거나, 대화를 계속하려고 하지 않나요?	예	아니오	1 2 3
자신이 해야 하는 일(의무)이나 관심이 있는 일을 하려는 동기가 줄었습니까?	예	아니오	1 2 3
예전에는 비해서 다정다감한 면이 줄었거나 감정이 부족합니까?	예	아니오	1 2 3
더 이상 아무 것도 신경 쓰지 않습니까?	예	아니오	1 2 3
기분이나 불안 증상에 관한 질문입니다.			
슬프거나 사무룩합니까? 눈물을 흘릴 때가 있습니까?	예	아니오	1 2 3
즐거움을 덜 느끼는 것 같습니까?	예	아니오	1 2 3
자신의 미래에 대해 낙담하거나 자신이 실패자라고 느낍니까?	예	아니오	1 2 3
자신이 가족에게 짐이 된다고 느낍니까?	예	아니오	1 2 3
일상적으로 하던 일들(예를 들면, 친척집 방문)에 대해서도 불안해 하거나 걱정합니까?	예	아니오	1 2 3
매우 긴장하고 있거나, 일을 떨거나, 공황증상을 느끼나요?	예	아니오	1 2 3
만족을 지양시키는 능력, 행동과 충동 및 성격을 통제하는 능력과 보상 변화에 관한 질문입니다.			
인질부질 지양하거나, 공격적이거나, 짜증을 잘 내거나, 신경질적으로 변합니까?	예	아니오	1 2 3
예전과는 달리 권히 터무니없이 따지기를 좋아합니까?	예	아니오	1 2 3
충동적이 되어서, 생각하지 않고 행동하는 것 같습니까?	예	아니오	1 2 3
평소 성격과 다르게 상대방을 기분 상하게 할 수 있는 방식으로 남을 만지거나 안으려고 하거나 손으로 다들하는 등의 성적으로 충동적이고 거슬리는 행동을 합니까?	예	아니오	1 2 3

Based on the ISTAART-AA Research Diagnostic Criteria for MBI ©2016
For more information contact Zahoor Ismail M.D. (MBIchecklist@gmail.com) or visit www.MBItest.org

전보다 쉽게 낙담하거나 활동성이 떨어졌습니까? 일이 지연되었을 때 그해 대처하거나 어떤 일이나 자신의 자리를 기다리는 것을 잘 하지 못합니까?	예	아니오	1 2 3
운전을 할 때 난독해 보이거나 편안을 잘 못하는 것 같습니까? (예를 들면, 과속, 갑자기 방향을 바꾸는 것, 갑작스런 차선 변경 등)	예	아니오	1 2 3
고집이 세지거나 융통성이 없어졌습니까? 예를 들면, 평소답지 않게 무조건 자기 방식만을 고집하거나, 다른 사람의 견해를 듣지도 보지도 않으려고 합니까?	예	아니오	1 2 3
섭식행동이 바뀌었습니까? (예를 들면, 너무 많이 먹거나, 한꺼번에 너무 많은 음식을 입에 넣거나, 특정 음식을 먹으려고 하거나, 매번 똑같은 순서로만 음식을 먹으려고 하는 것)	예	아니오	1 2 3
더 이상 음식을 맛있게 먹는 것 혹은 즐거움 것으로 생각하지 않습니까? 이전보다 적게 먹습니까?	예	아니오	1 2 3
이전에는 모지 않았던 물건들을 모아서 쌓아두니까?	예	아니오	1 2 3
단순한 동작을 반복하거나 특정한 행동을 강박적으로 반복합니까?	예	아니오	1 2 3
최근 들어 음면, 음주, 약물 복용, 도박 문제를 일으키거나 가계 물건을 훔치기 시작했습니까?	예	아니오	1 2 3
사회적인 규범을 따르기와 사회적인 예의, 재치 및 공감능력에 관한 질문입니다.			
자신의 말이나 행동이 다른 사람에게 어떤 영향을 미칠지에 관해서 덜 고려합니까? 다른 사람의 감정에 둔감했습니까?	예	아니오	1 2 3
보통은 공개적으로 논의되지 않는 매우 개인적이거나 사적인 일들을 공공연하게 말합니까?	예	아니오	1 2 3
전에는 하지 않았던 무례하거나 상스러운 말을 하거나 외설적인 성적인 이야기를 합니까?	예	아니오	1 2 3
사람들이 있는 장소나 사적인 장소에서 어떻게 말하고 어떻게 행동해야 하는지에 대한 사회적인 판단력이 저하된 것 같습니까?	예	아니오	1 2 3
전혀 모르는 사람에게 마치 잘 알고 있는 것처럼 말을 건네거나, 모르는 사람들의 일에 끼여들니까?	예	아니오	1 2 3
강하게 지니고 있는 믿음과 감각 경험에 관한 질문입니다.			
자신이 위험에 처해 있다고 믿거나, 다른 사람들이 자신을 해치려 하거나 자신의 물건을 훔치려고 한다고 믿고 있다고 믿고 있습니까?	예	아니오	1 2 3
다른 사람들의 의도나 행위에 대해서 의심합니까?	예	아니오	1 2 3
자신의 힘(관력)이나 재산이나 능력에 대해서 비현실적인 신념(생각)을 가지고 있습니까?	예	아니오	1 2 3
어떤 목소리를 듣는다고 말하거나 상상 속의 인물이나 "영혼"과 대화를 할 때가 있습니까?	예	아니오	1 2 3
다른 사람들은 보지 못하는 거기에 있는 것들(예를 들면, 사람, 동물, 별)을 보는 것처럼 말하거나 행동합니까?	예	아니오	1 2 3

Contact Yeonwook Kang, Ph.D. (ykang@hallym.ac.kr) for the Korean version
Based on the ISTAART-AA Research Diagnostic Criteria for MBI ©2016
For more information contact Zahoor Ismail M.D. (MBIchecklist@gmail.com) or visit www.MBItest.org

그림 2.

크리스트)를 실시하여 16점으로(그림 2), SCD(주관적 인지 저하)에서의 경도 행동장애(mild behavioral impairment, MBI)로 최종 진단하였다.

환자는 1년 뒤, MRI(그림 3), amyloid PET 검사(그림 4)를 시행하였으며, MRI에서는 medial temporal atrophy를 보인 않았으나, amyloid PET(flortetaben)

에서는 bilateral lateral temporal cortex, frontal cortex, parietal cortex와 precuneus/posterior cingulate regions에 diffuse uptake가 관찰되었다.

고찰

MBI는 2003년, Taragano 등에 의해 처음으로 제안되었으며, 주로 FTD(전두측두치매)로 진행될 위험이 큰 군으로 알려졌다.

전형적인 치매 환자의 인지 기능 저하가 없는 상태에서 정신, 행동 증상을 보이는 경우에 진단할 수 있으며, FTD(44.5%)뿐 아니라 최근에는 알츠하이머병(22.7%) 및 루이소체치매(4.2%) 위험군으로도 보고되고 있다. 알츠하이머병의 병리학적 관련성에 대한 많은 증거들이 알려져 있다. 2013년 새롭게 제안된 진단기준에서는 50세 이후에 발병하고, 최소한 6개월 이상 증상을 보이는 경우 진단할 수 있다(표 1).

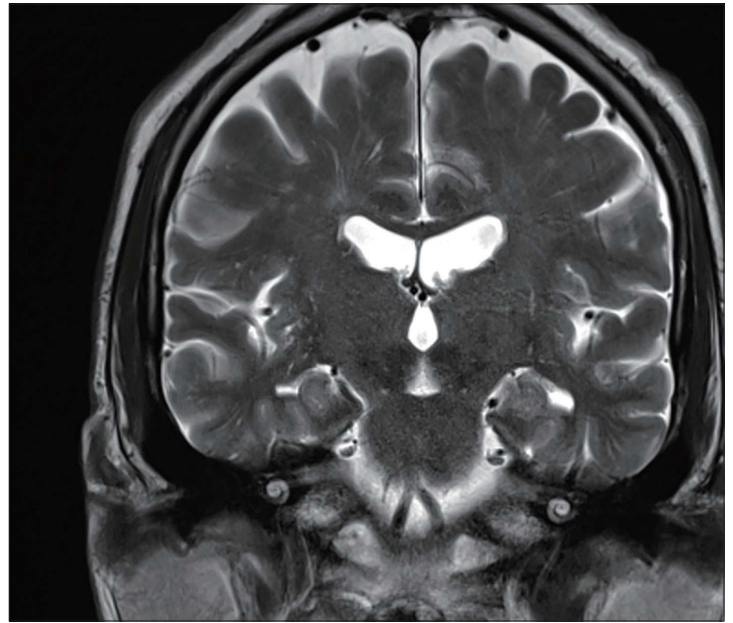


그림 3.

표 1.

ISTAART-AA MBI Criteria
- Changes in behavior or personality observed by patient or informant or clinician, starting later in life(age ≥ 50) and persisting at least intermittently for ≥ 6 months. These represent clear change from the person's usual behavior or personality as evidenced by at least one of the following: - Decreased motivation(e.g. apathy, asponaneity, indifference) - Affective dysregulation(e.g. anxiety, dysphoria, changeability, euphoria, irritability) - Impulse dyscontrol(e.g. agitation, disinhibition, gambling, obsessiveness, behavioral perseveration, stimulus bind) - Social inappropriateness(e.g. lack of empathy, loss of insight, loss of social graces or tact, rigidity, exaggeration of previous personality traits) - Abnormal perception or thought content(e.g. delusions, hallucinations) - Behaviors are of sufficient severity to produce at least minimal impairment in at least one of the following areas: - Interpersonal relationships - Other aspects of social functioning - Ability to perform in the workplace The patient should generally maintain his/her independence of function in daily life, with minimal aids or assistance. - Although co-morbid conditions may be present, the behavioral or personality changes are not attributable to another current psychiatric disorder(e.g. generalized anxiety disorder, major depression, manic or psychotic disorders), traumatic or general medical causes, or the physiological effects of a substance or medication. - The patient does not meet criteria for a dementia syndrome(e.g., Alzheimer's dementia, frontotemporal dementia, dementia with Lewy bodies, vascular dementia, other dementia). Mild Cognitive Impairment(MCI) can be concurrently diagnosed with Mild Behavioral Impairment.

Note. ISTAART=International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment.

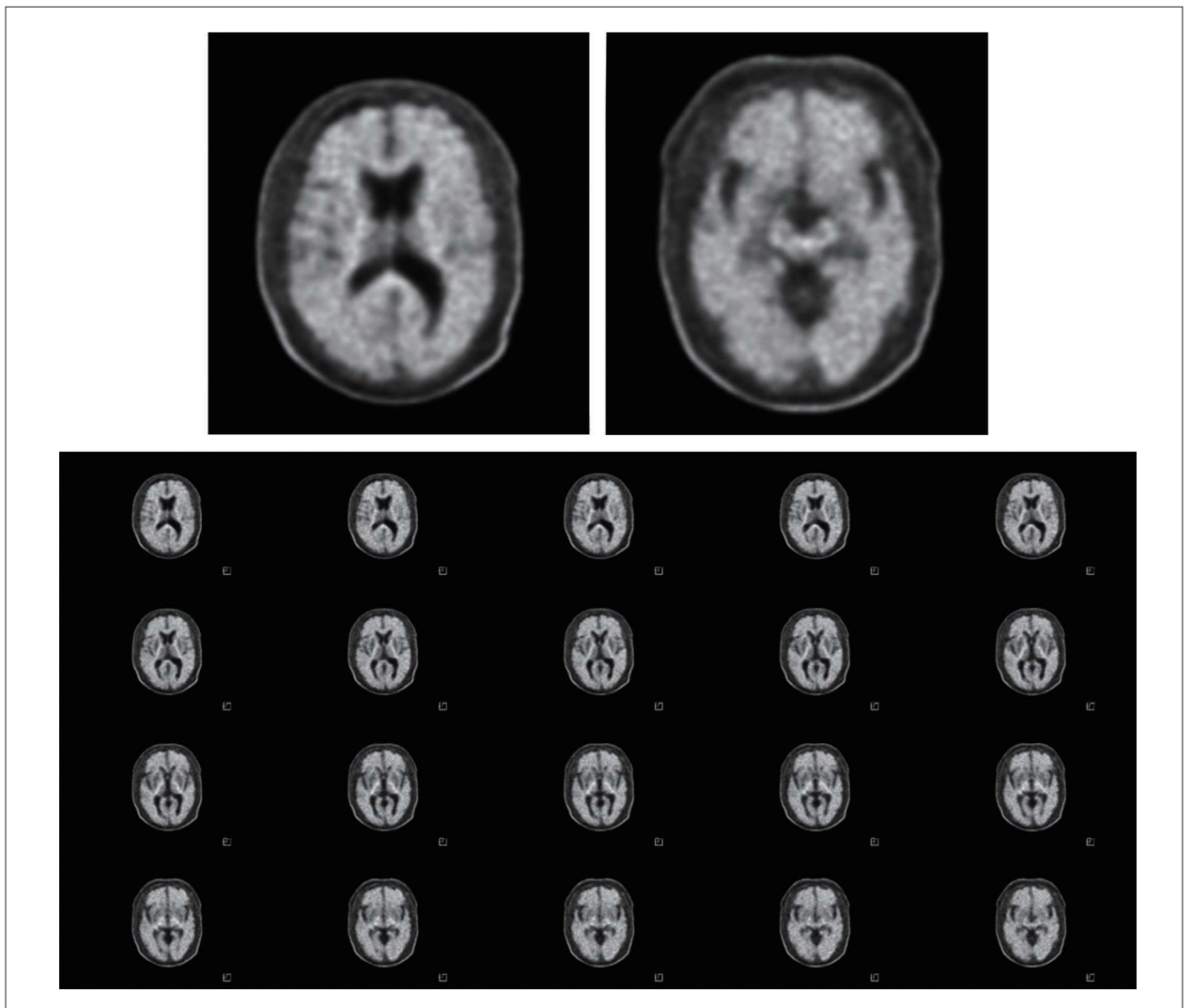


그림 4.